

Anamnese:

Reinkommen, Hände desinfizieren, sich vorstellen (Name, Funktion, Zeitrahmen, Absicht)

Jetziges Leiden

- offene Frage («Was bringt Sie heute zu mir») -> WWSZ für ca. 2 min.
- fokussierte Fragen (5 Dimensionen: Lokalisation/Ausstrahlung, Stärke, Charakter, Beginn/Verlauf, Begleitsymptome, lindernde/verstärkende Umstände)
- «schon mal gehabt?»
- Zusammenfassung

Persönliche Anamnese

- Bestehende Erkrankungen (z.B. Diabetes, Bluthochdruck)
- medizinische Vorgeschichte (Erkrankungen, Operationen)
- Medikamente (z.B. Pille), Allergien, Noxen (Alkohol, Tabak, sonstige Drogen)

Systemanamnese

- B-Symptome (Gewichtsabnahme, Fieber, Nachtschweiss)
- Allgemeinsymptomatik (Müdigkeit, Durst/Appetit, Schwitzen)
- Kopf/Hals (ZNS, Augen, Ohren)
- Respirationstrakt
- Herz/Kreislauf
- Verdauungstrakt
- Urogenitaltrakt
- Gyni
- Bewegungsapparat

Sozialanamnese

- Soziales Umfeld, Familienbedingungen, Wohnsituation
- Berufsanamnese (gesundheitliche Risiken)
- Reiseanamnese

Familienanamnese

- ähnliches Krankheitsbild in der Familie
- Erbkrankheiten
- Krankheiten mit Vererbungstendenz

Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

Ablauf einer Patientenvorstellung:

(Details siehe Vorlesung «Wie werden Patienten nach einer guten Anamnese im klinischen Alltag richtig vorgestellt»)

1. Name, Vorname, Alter
2. Hauptbeschwerden/Fragestellung (was hat zu Arztbesuch/ Hospitalisation/ Konzilium geführt?)
3. Wichtigste Grundkrankheiten
4. Jetziges Leiden (das wichtigste in ganzen Sätzen zusammenfassen), z.B. bei Schmerzen:
 - Wo
 - Wann
 - Stärke (VAS 1-10)
 - Schmerzcharakter
 - Ausstrahlung
 - Bessernde/ verschlechternde Begleitumstände
 - Begleitbeschwerden
5. Persönliche Anamnese
6. Medikamente, Nahrung, Allergien
7. Sozial- und Familienanamnese
8. Labor, EKG, Rx-Thorax, andere Befunde
9. Beurteilung/ Verdachtsdiagnose /DD
10. Diagnostisches Procedere
11. Therapeutisches Procedere

für allfällige Rückfragen:

Tutoren SOKO 2018:

Lukas Boos	lukas.boos@stud.unibas.ch
Michaela Schumacher	m.schumacher@unibas.ch
Madlaina Helbling	madlaina.helbling@stud.unibas.ch

Handout zum angeleiteten Üben 2017/18

Dieses Handout wurde von den studentischen Tutorinnen und Tutoren des angeleiteten Übens zur Orientierung während des Kurses und in der anschliessenden Selbstlernphase erstellt. Die Handouts wurden nicht von den Lehrverantwortlichen überprüft und können kein Lehrbuch ersetzen.

WWSZ

- Warten → >3 Sekunden
- Wiederholen → einzelne Worte
- Spiegeln → auf Emotionen oder Inhalt
- Zusammenfassen → mit Ankündigung, in eigenen Worten

Mit dem Akronym «WWSZ» werden 4 typische Techniken der patientenzentrierten Gesprächsführung beschrieben, von denen W, W und S den Raum für den Patienten öffnen/offenhalten sollten und Z vor allem als Qualitätskontrolle dient.

NURSE – Umgang mit Emotionen

- Naming → Emotionen benennen (wie «Spiegeln» aus WWSZ)
- Understanding → Verständnis zeigen
- Respecting → Respekt äussern
- Supporting → Unterstützung anbieten
- Exploring → Hintergründe explorieren

Hinter diesem Akronym verbergen sich 5 Techniken, die im Umgang mit emotionalen Äusserungen eines Patienten/in hilfreich sind.

Leventhal – Common sense model of illness

→ Zur Exploration von Krankheitskonzepten des Patienten.

- Identity → Was ist das?
- Cause → Was ist die Ursache?
- Consequences → Was sind die Folgen?
- Time Line → Wie ist der zeitliche Verlauf?
- Control → Wie kann man das behandeln?

Mit dem «Common sense model of illness» kann/soll der Patient dazu gebracht werden zu erzählen, wie er über eine Krankheit denkt, bzw was seine Vorstellungen davon sind.
Weiss man in etwa, wo der Patient steht, kann man ihn später einfacher abholen oder erkennen, wieso der Patient zB eine Therapie verweigert.

Die Buchmetapher

Die Buchmetapher wird angewandt zur Vermittlung von komplexen Informationen und hilft, dem Arzt das Arzt-Patienten-Gespräch für den Patienten so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Es wird ein Überblick gegeben und die zu besprechenden Punkte werden thematisch gegliedert. Die Buchmetapher kann in jedem Gespräch angewandt werden.

Gespräch gliedern in:

ein Beispiel:

• Titel

Titel : „Ich würde gerne heute mit Ihnen über ihre Beschwerden sprechen“

• Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis:

- Kapitelüberschriften
 - „3 Fragen, die wir klären müssen:
 - Was ist die Ursache für ihre Beschwerden - die Diagnose,
 - Was kann man dagegen tun - die Therapie
 - und was sind die Beschwerden, bei denen Sie mich sofort rufen müssen“
- Text
- Anhang

Kapitelüberschriften :

“Erst mal zur Frage der Ursache der Beschwerden - die Diagnose.“